

Prévention du diabète en milieu professionnel : rôle du dépistage et enjeux de santé au travail

M. HAMADOUCHE^{1,2}, A. BOUDIB^{1,2}, K. GHARBI^{1,2}, D. BENSEGHIR^{1,2}, A. BOUKRAA^{1,2}

¹Service de médecine du travail, CHU Saadna Abdenour Sétif.

²Université Sétif1 Ferhat Abbas

Intérêt de la prévention et du dépistage du diabète en milieu de travail

- Le diabète constitue aujourd'hui un véritable problème de santé publique.
- Il touche principalement les personnes âgées, mais sa fréquence augmente également chez les personnes en âge d'activité professionnelle et, de manière préoccupante, chez les sujets plus jeunes.
- On estime qu'environ un tiers des personnes atteintes de diabète ignorent leur maladie.
- Un diabète non diagnostiqué ou insuffisamment pris en charge peut avoir des répercussions sur la santé, la vigilance, les performances professionnelles et l'absentéisme.
- Le milieu de travail représente un cadre privilégié pour la prévention, le dépistage précoce et l'accompagnement des maladies, chroniques.
- Les actions de promotion de la santé en entreprise peuvent ainsi contribuer à améliorer la santé et le bien-être des travailleurs, tout en bénéficiant également aux employeurs.
- Agir précocement permet de réduire le risque de complications, de favoriser une meilleure qualité de vie et de contribuer à un environnement de travail plus sain et plus sûr.
- Intégrer la prévention et le dépistage du diabète dans les programmes de santé au travail constitue ainsi une démarche à la fois humaine, préventive et économiquement pertinente.

Principaux facteurs de risque du diabète de type 2

- Âge : > 45 ans
- Surpoids
- Tour de taille : > 94 cm (hommes) et 80 cm (femmes)
- Sédentarité
- Tabagisme



- HTA
- Mauvaises habitudes alimentaires : alimentation riche en sucres rapides et graisses saturées
- Antécédents familiaux de diabète
- Antécédent de diabète gestationnel

Calculateur de risque: FINDRISC

NOTE	RISQUE	RECOMMANDATION
0-14 points	Risque faible à modéré : 1 à 17 % de risque d'être diabétique dans les 10 prochaines années	Nous recommandons de ne pas faire de dépistage pour le diabète de type 2.
15-20 points	Risque élevé : 33 % de risque d'être diabétique dans les 10 prochaines années	Nous recommandons de faire un dépistage tous les 3 à 5 ans avec l'hémoglobine A1C.
21+ points	Risque très élevé : 50 % de risque d'être diabétique dans les 10 prochaines années	Nous recommandons de faire un dépistage annuel avec l'hémoglobine A1C.

Diagnostic du diabète lors d'un dépistage

Le diagnostic de diabète est souvent porté chez un patient asymptomatique, dans le contexte d'un dépistage en raison des facteurs de risque par exemple.

Glycémie veineuse à jeun

- Glycémie normale < 1,10 g/l [6 mmol/l]
- Hyperglycémie modérée : ≥ 1,10 g/l et < 1,26 g/l [6 à 7 mmol/l]
- Diabète sucré si la glycémie à jeun est ≥ 1,26 g/l à deux reprises

Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO, 75 g de glucose en 10 minutes)

- En dehors de la grossesse, une HGPO n'est indiquée que dans le cas d'une anomalie modérée de la glycémie à jeun, entre 1,10 et 1,26 g/l [6 à 7 mmol/l]
- Diagnostic de diabète si la glycémie 2 heures après charge orale ≥ 2 g/l [11 mmol/l]
- Glycémie à 2 heures entre 1,40 et 2,0 g/l [7,8 à 11 mmol/l] : intolérance au glucose

HbA1c

Diagnostic du diabète : valeur seuil : 6,5 %.



DIABÈTE, NE VOUS LAISSEZ PAS ATTRAPER. TESTEZ-VOUS !

